Клинические рекомендации

Рак носоглотки

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C11** — Злокачественное новообразование носоглотки
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/535_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 3

2.3 Клиническая картина 4

2.4 Гистологические варианты 4

2.5 Классификация TNM (8-е издание) 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Передняя и задняя риноскопия 5

3.4 ДНК вируса Эпштейна — Барр в крови 5

3.5 Эндоскопическая эндоназальная ревизия носоглотки 5

3.6 УЗИ лимфатических узлов шеи 5

3.7 МРТ и КТ лицевого отдела черепа и шеи 6

3.8 КТ органов грудной полости и ПЭТ-КТ 6

3.9 Оценка эффективности лечения 6

4. Лечение 6

4.1 Лечение по стадиям 6

4.2 Рецидив или остаточная опухоль после лучевой терапии 7

4.3 Лучевая терапия 7
4.4 Лекарственное лечение 7
4.5 Профилактика и лечение осложнений 8
4.6 Медицинская реабилитация 8
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9
5.1 Диспансерное наблюдение 9
5.2 Организация медицинской помощи 9
6. Источник и актуальность 10
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Рак носоглотки — злокачественная опухоль, развивающаяся из неороговевающего эпителия носоглотки.
- Начальные проявления в большинстве случаев скрываются под маской ОРВИ, ринофарингита, аденоидных вегетаций; нередко первым признаком становятся увеличенные лимфоузлы шеи.
- Повод заподозрить опухоль — затруднение носового дыхания, гнусавость, заложенность или пощёлкивание в ухе, снижение слуха, образование на шее.
- Диагноз подтверждает эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки с биопсией; распространённость оценивают по МРТ (предпочтительно) или КТ лицевого отдела черепа и шеи.
- Основным методом радикального лечения является лучевая или химиолучевая терапия.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Стенки носоглотки

1. **верхняя** — основная кость, часть затылочной кости;
2. **задняя** — I и II шейные позвонки;
3. **передняя** — хоаны;
4. **боковые** — глоточные отверстия слуховых труб;
5. **нижняя** — твёрдое нёбо.

Оценка эффекта лечения

1. **полный эффект** — отсутствие признаков опухоли по данным лабораторных и инструментальных методов;
2. **частичная регрессия** — сокращение опухолевых очагов более чем на 50% при отсутствии новых;
3. **прогрессирование** — новый очаг и (или) рост первичного или метастатических очагов более чем на 25%.

2.2 Этиология

Этиологические факторы

1. инфицирование вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ);
2. хронические воспалительные процессы, вызывающие гиперплазию и метаплазию слизистой оболочки носоглотки;
3. анатомические особенности некоторых рас: более высокая заболеваемость у народов Юго-Восточной Азии, Африки, Индокитая.

Канцерогенные факторы

1. курение, в том числе пассивное;
2. контакт с асбестом, древесной пылью, продуктами нефтепереработки;
3. ионизирующее излучение;
4. вирус Эпштейна — Барр.

Заболеваемость раком носоглотки в России в 2023 г. составила 0,36 на 100 тыс. населения; у мужчин — 0,53, у женщин — 0,2 на 100 тыс.

2.3 Клиническая картина

Клиническая картина складывается из местных симптомов, признаков регионарного и отдалённого метастазирования, общего опухолевого симптомокомплекса. Начальные проявления в большинстве случаев маскируются под ОРВИ, ринофарингит, аденоидные вегетации; нередко к врачу заставляют обратиться увеличенные лимфоузлы шеи.

На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно; симптомы зависят от локализации опухоли и направления её роста.

Первичные симптомы

1. прогрессирующее затруднение носового дыхания, гнусавость;
2. пощёлкивание или заложенность уха, снижение слуха, боль в ухе;
3. головная боль, кровотечения;
4. экзофтальм, птоз, косоглазие;
5. тризм жевательной мускулатуры, расстройство глотания и фонации;
6. провисание мягкого нёба, неподвижность половины гортани, отклонение языка в сторону;
7. образования на шее.

2.4 Гистологические варианты

Среди злокачественных опухолей носоглотки преобладают эпителиальные; рак составляет около 70%.

Гистологические варианты рака носоглотки

1. плоскоклеточный ороговевающий рак;
2. плоскоклеточный неороговевающий рак (дифференцированный и недифференцированный);
3. базалоидный вариант плоскоклеточного рака.

2.5 Классификация TNM (8-е издание)

Символ T

T	Первичная опухоль
T0	первичная опухоль не определяется, но имеется поражение регионарных лимфоузлов, связанное с ВЭБ
Tis	преинвазивная карцинома
T1	в пределах носоглотки или с распространением в ротоглотку или полость носа без распространения в парафарингеальное пространство
T2	распространение в парафарингеальное пространство
T3	распространение на основание черепа и (или) придаточные пазухи носа
T4	интракраниальное распространение и (или) поражение черепных нервов, распространение в орбиту, подвисочную ямку, жевательное пространство

1. **N1** — метастазы в шейных лимфоузлах выше надключичной ямки на стороне поражения не более 6 см и (или) одно- или двусторонние ретрофарингеальные не более 6 см;
2. **N2** — двусторонние метастазы в шейных лимфоузлах выше надключичной ямки до 6 см;
3. **N3** — метастазы более 6 см и (или) ниже нижнего края перстневидного хряща.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
0 / I / II / III	TisN0 / T1N0 / T0–T1N1, T2N0–N1 / T0–T2N2, T3N0–N2

Стадия	TNM
IVA / IVB / IVC	T4N0–N2 / любая T N3 / M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнестических данных;
2. клинической картины и осмотра с пальпацией регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования отделяемого верхних дыхательных путей, отпечатков, пунктата увеличенных лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: фиброларингоскопия, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ по показаниям;
6. определения ДНК вируса Эпштейна — Барр.

3.2 Жалобы и анамнез

Всем с подозрением на рак носоглотки — тщательный сбор жалоб и анамнеза; стаж курения оценивают в пачка-летах.

Факторы риска

1. курение, употребление крепких спиртных напитков;
2. производственные вредности;
3. хроническая инфекция: хронический фарингит, отит, ринит, вирус Эпштейна — Барр.

3.3 Передняя и задняя риноскопия

При подозрении на рак носоглотки — передняя и задняя риноскопия, пальпация регионарных лимфоузлов, оценка нутритивного статуса.

3.4 ДНК вируса Эпштейна — Барр в крови

Всем с раком носоглотки или подозрением на него — количественное определение ДНК ВЭБ методом ПЦР в периферической крови для верификации опухоли и оценки эффекта лечения.

ДНК ВЭБ методом ПЦР в реальном времени выявлена у 96% пациентов с раком носоглотки и у 7% здоровых. Высокий исходный или сохраняющийся к концу ЛТ уровень ДНК ВЭБ связан с неблагоприятным прогнозом.

3.5 Эндоскопическая эндоназальная ревизия носоглотки

Всем с подозрением на рак носоглотки — эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки с биопсией и мазками-отпечатками с поверхности эрозий и изъязвлений, пункцией уплотнений без изъязвления.

3.6 УЗИ лимфатических узлов шеи

Всем — УЗИ лимфоузлов шеи с обеих сторон с пункцией подозрительных узлов для цитологического и патологоанатомического исследования.

При подозрении на метастазы в лимфоузлах шеи — цитологическое исследование материала тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем УЗИ.

3.7 МРТ и КТ лицевого отдела черепа и шеи

Всем для оценки распространённости опухоли — КТ лицевого отдела черепа с болюсным контрастированием и (или) МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием. Предпочтительна МРТ; КТ дополняет её при опухоли у основания черепа для оценки костной деструкции.

Зона исследования шеи — от основания черепа до верхней апертуры грудной клетки, при поражении лимфоузлов ниже перстневидного хряща — до бифуркации трахеи. При большом интракраниальном компоненте дополнительно выполняют МРТ головного мозга.

Для планирования ЛТ — МРТ лицевого отдела черепа с контрастированием; КТ с болюсным контрастированием — для оценки распространения на кости основания черепа. При невозможности МРТ выполняют КТ или ПЭТ-КТ.

3.8 КТ органов грудной полости и ПЭТ-КТ

Стадирование

1. КТ органов грудной полости; при невозможности — прицельная рентгенография органов грудной клетки;
2. ПЭТ-КТ с ФДГ — при местно-распространённом процессе и метастазах в регионарных лимфоузлах для поиска отдалённых метастазов.

3.9 Оценка эффективности лечения

1. МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием через **2–3 месяца** после ЛТ или ХЛТ; при неоднозначном результате — ПЭТ-КТ для отличия постлучевых изменений от рецидива;
2. при регионарных метастазах — ПЭТ-КТ **не ранее чем через 3 месяца** после ЛТ или ХЛТ для решения вопроса о шейной лимфодиссекции;
3. через **2–3 месяца** — пункция подозрительных лимфоузлов шеи под контролем УЗИ для решения вопроса об отказе от лимфаденэктомии.

Подозрительными считают лимфоузлы шеи I–IV групп **более 2 см**, V группы **более 1 см**, а также узлы с изменённой структурой по данным УЗИ.

---

4. Лечение

4.1 Лечение по стадиям

Основным методом радикального лечения является лучевая или химиолучевая терапия.

Лечение рака носоглотки по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
T1N0M0	самостоятельная ЛТ
T2N0M0	самостоятельная ХЛТ
T1N1–3, T2–T4 любая N	одновременная ХЛТ, затем адъювантная ХТ (2 цикла), или индукционная ХТ (3 цикла), затем одновременная ХЛТ
любая T и N, M1	ХТ с препаратами платины, предпочтительно в сочетании с камрелизумабом в 1-й линии независимо от экспрессии PD-L1 и статуса ВЭБ

При остаточных метастатических лимфоузлах после консервативного лечения целесообразно хирургическое лечение; при полной регрессии узлов — динамическое наблюдение.

После ХЛТ при местно-распространённом раке III–IVA стадии (кроме T3–4N0 и T3N1) может быть рассмотрена адъювантная ХТ #капецитабином 650 мг/м² 2 раза в сутки в течение 1 года, начатая **не позднее 12–16 недель** после ХЛТ.

Индукция по схеме DCF (доцетаксел, цисплатин, фторурацил) с последующей ХЛТ при T3–4N+ улучшает 3-летнюю безрецидивную и общую выживаемость по сравнению с одновременной ХЛТ.

4.2 Рецидив или остаточная опухоль после лучевой терапии

В 1-й линии — ХТ с препаратами платины, предпочтительно в сочетании с камрелизумабом. При резектабельной опухоли обсуждают операцию и повторную ЛТ или ХЛТ; при нерезектабельной — повторную ЛТ или ХЛТ, лекарственную терапию либо симптоматическое лечение.

Повторная ЛТ обсуждается при общем состоянии ECOG 0–1 и **не ранее 6 месяцев** (предпочтительно **не ранее 2 лет**) после предшествующего облучения.

Рецидив или остаточная опухоль с отдалёнными метастазами

1. **ECOG 0–1** — лекарственное лечение: полихимиотерапия, монохимиотерапия или иммунотерапия с учётом первичного лечения;
2. **ECOG 2** — монохимиотерапия или симптоматическое лечение;
3. **ECOG 3** — симптоматическое лечение.

4.3 Лучевая терапия

Самостоятельная ЛТ: на первичный очаг 66–70 Гр (1,8–2,2 Гр за фракцию), на локорегионарную область с лимфоузлами 50 Гр (2,0 Гр за фракцию) или 54–63 Гр (1,6–1,8 Гр за фракцию).

Одновременная ХЛТ: на первичный очаг и регионарные метастазы 70 Гр (2,0 Гр за фракцию) ежедневно с понедельника по пятницу **в течение 7 недель**; на локорегионарную область — 50 Гр или 54–63 Гр.

Паллиативная ЛТ — для облегчения или профилактики локорегионарных симптомов при невозможности радикального лечения, в том числе 50 Гр (2,5 Гр за фракцию) или 30 Гр (3 Гр за фракцию).

ЛТ проводят в специализированных учреждениях с опытом лечения рака носоглотки. Предпочтительны высокопрецизионные методы (IMRT, VMAT), при значительных ограничениях дозы на нормальные ткани — протонная терапия; допустима 3D-конформная ЛТ.

4.4 Лекарственное лечение

При одновременной ХЛТ — цисплатин 100 мг/м² на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ (суммарно 300 мг/м²). После индукционной ПХТ альтернатива цисплатину — карбоплатин AUC 1,5–2,0 еженедельно с первого дня ЛТ.

Схемы индукционной ХТ

1. доцетаксел 75 мг/м² и цисплатин 75 мг/м² в 1-й день, фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни; 3 цикла с интервалом 3 недели;
2. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни и цисплатин 80 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели; 3 цикла;
3. #гемцитабин 1000 мг/м² и цисплатин 40 мг/м² в 1-й и 8-й дни каждые 3 недели; 3 цикла.

ХЛТ с последующей адъювантной ХТ: цисплатин 100 мг/м² 1 раз в 3 недели или 40 мг/м² еженедельно на фоне ЛТ.

Схемы адъювантной ХТ

1. цисплатин 80 мг/м² в 1-й день и фторурацил 1000 мг/м²/сут в 1–4-й дни каждые 4 недели, 3 цикла; при невозможности введения цисплатина — карбоплатин;
2. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни и цисплатин 80 мг/м² в 1-й день каждые 4 недели, 3 цикла;
3. #гемцитабин 1000 мг/м² и цисплатин 30 мг/м² в 1-й и 8-й дни каждые 3 недели, 3 цикла;
4. #капецитабин 650 мг/м² внутрь 2 раза в сутки в течение года.

При рецидиве и отдалённых метастазах в 1-й линии — камрелизумаб 200 мг в 1-й день, #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни, цисплатин 80 мг/м² в 1-й день; курс 21 день, 4–6 курсов, далее камрелизумаб 200 мг каждые 3 недели до прогрессирования или непереносимой токсичности.

При невозможности химиоиммунотерапии — комбинированная ХТ (карбоплатин с #паклитакселом, цисплатин с #доцетакселом или фторурацилом, карбоплатин с фторурацилом, #гемцитабин с цисплатином) или монохимиотерапия; число курсов определяется переносимостью и эффективностью.

Во 2-й линии — один из этих режимов, пембролизумаб при MSI или CPS более 1 либо ниволумаб, если 1-я линия не содержала камрелизумаб.

4.5 Профилактика и лечение осложнений

При угрозе или состоявшемся кровотечении из опухоли или метастатических узлов — ангиография наружной сонной артерии и при отсутствии противопоказаний селективная и суперселективная эмболизация сосудов опухоли.

На фоне противоопухолевой лекарственной терапии проводят профилактику и лечение тошноты и рвоты, фебрильной нейтропении, гепато-, нефро- и кардиотоксичности, кожных реакций, мукозитов, анемии, иммуноопосредованных и неврологических осложнений по КР Российского общества клинической онкологии.

4.6 Медицинская реабилитация

До начала лечения — профилактическая гимнастика и обучение тактике глотания для уменьшения нарушений глотания на фоне противоопухолевой терапии.

Всем перед ЛТ или ХЛТ — осмотр стоматолога и сопровождение на всех этапах лечения и реабилитации.

В постлучевом периоде облучённые ткани очень ранимы: **в ранние сроки** инвазивные диагностические процедуры и биопсию без крайней необходимости не выполняют.

Частая причина лучевого остеомиелита — удаление зубов в зоне облучения; по возможности ограничиваются консервативными методами, удаление зубов — только при необходимости на фоне антибиотикотерапии.

Показания к нутритивной поддержке перед операцией

1. непреднамеренная потеря **10% массы тела и более** за 6 месяцев;
2. индекс массы тела **менее 20 кг/м²**;
3. гипопротеинемия **менее 60 г/л** или гипоальбуминемия **менее 30 г/л**;
4. ухудшение возможности приёма пищи за последнюю неделю.

При химиотерапии показания те же, но потеря массы тела — более 5% за 6 месяцев; добавляются невозможность адекватного питания через рот и энтеропатия средней и тяжёлой степени.

Энтеральное питание начинают, если питание через рот покрывает менее 60% потребности **в течение 10 дней**; потеря более 10% исходной массы тела также является показанием. Предпочтителен сиппинг высокобелковыми смесями; при невозможности — назогастральный зонд (при сроке стояния **до 3–4 недель**) или гастростомия. Белок — не менее 1,2–2 г/кг/сут, энергия — 25–30 ккал/кг/сут.

При болевом синдроме на фоне ЛТ или ХЛТ — консультация врача по паллиативной медицинской помощи.

На фоне ХЛТ для профилактики и лечения мукозита полости рта и глотки применяют низкоинтенсивное лазерное излучение на область дёсен.

На фоне химиотерапии рекомендуется раннее начало физических нагрузок для профилактики саркопении, уменьшения слабости и улучшения качества жизни.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Осмотр и сбор жалоб после лечения

1. 1-й год — **каждые 1–3 месяца**;
2. 2-й год — **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5-й год — **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет — ежегодно или при появлении жалоб; при высоком риске рецидива интервалы сокращают.

Объём обследования

1. анамнез и физикальное обследование;
2. КТ или МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием;
3. эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки;
4. КТ органов грудной полости каждые 12 месяцев;
5. ПЭТ всего тела **не ранее чем через 1 год** после окончания ЛТ;
6. ТТГ в крови каждые 6–12 месяцев, если облучали шею.

При невозможности адекватного осмотра зоны интереса — фиброларингоскопия **каждые 3 месяца** в первые 2 года после лечения, в 3–5-й год — каждые 4–8 месяцев, далее раз в год.

УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон — **каждые 1–3 месяца** в первые 2 года, в 3–5-й год — каждые 4–8 месяцев, далее раз в год.

КТ или МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием — с той же периодичностью, что и УЗИ шеи.

КТ органов грудной полости — каждые 6 месяцев **до 5 лет**, далее раз в год; при невозможности — прицельная рентгенография.

При симптомах рецидива — ПЭТ-КТ с ФДГ или КТ органов грудной и брюшной полостей с контрастированием; при невозможности — рентгенография органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости.

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой врач направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи или первичный онкологический кабинет.

Тактику лечения определяет онкологический консилиум с участием онкологов и радиотерапевта.

Показания к госпитализации

1. **экстренная** — осложнения онкологического заболевания или его лечения;
2. **плановая** — сложные интервенционные диагностические вмешательства; специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в круглосуточном или дневном стационаре.

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки опухоли;
3. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость);
4. экстранодальное распространение опухоли.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак носоглотки»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2029 года
Код в рубрикаторе	535_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 3.1 при стадии T2N0M0 рекомендована самостоятельная ХЛТ, а следующий пункт для «T2–T4, любого N» рекомендует ХЛТ с адъювантной или индукционной химиотерапией: стадия T2N0 подпадает под оба пункта.
- Сроки наблюдения расходятся: в разделе 2.4.3 фиброларингоскопия — «каждые 3 месяца в течение первых двух лет…, каждые 2–6 месяцев в течение 2 лет», КТ органов грудной полости — каждые 6 месяцев до 5 лет; в разделе 5 КТ органов грудной полости — каждые 12 месяцев.